

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Informe de Evaluación Neuropsicológica

Variante Medicolegal

PACIENTE

Ricardo Pinzón

DOCUMENTO
CC 79456789

FECHA DE NACIMIENTO
—

EDAD
41a 1m

SEXO
M

ESCOLARIDAD
Universitaria

LATERALIDAD
—

FECHA DE EVALUACIÓN
—

ORDEN N°
—

Alcance del Informe

Limitaciones y propósito del presente documento

Lectura del informe

Este informe describe el funcionamiento cognitivo y conductual del evaluado en el momento de la evaluación. No constituye por sí mismo un dictamen médico-legal ni de imputabilidad. La interpretación de los hallazgos en el marco de un proceso judicial o administrativo es competencia exclusiva de la autoridad o el equipo pericial al que se remite, quienes deberán integrarlo con la totalidad del acervo probatorio.

Información Sociodemográfica

NOMBRE COMPLETO Ricardo Pinzón		DOCUMENTO CC 79456789	
FECHA DE NACIMIENTO —	EDAD 41a 1m	SEXO M	
ESCOLARIDAD Universitaria	OCUPACIÓN —	LATERALIDAD —	
CIUDAD —	ACOMPañANTE —	REMITE —	
EPS / ASEGURADOR —	ORDEN N° —	FECHA DE ATENCIÓN —	

Motivo de Consulta

MOTIVO REFERIDO POR EL CONSULTANTE

Sospecha de TDAH de inicio tardío.

Antecedentes Médicos

Historia clínica relevante — todas las áreas se consignan aunque no se reporten

PATOLÓGICOS / MÉDICOS

No reportado

ALÉRGICOS

No reportado

SENSORIALES / MOTORES

No reportado

TÓXICOS

No reportado

PSIQUIÁTRICOS

No reportado

TERAPÉUTICOS

No reportado

FARMACOLÓGICOS

No reportado

QUIRÚRGICOS

No reportado

TRAUMÁTICOS

No reportado

FAMILIARES

No reportado

PARACLÍNICOS

No reportado

Observación Clínica

Apariencia, actitud y conducta durante la evaluación

OBSERVACIÓN GENERAL

No reportado

Validez de Síntomas y Esfuerzo

Consideración crítica para informe pericial

Advertencia metodológica

No se incluyeron pruebas formales de validez de síntomas (PVT/SVT) en esta evaluación. La interpretación se realiza asumiendo que el paciente colaboró con esfuerzo óptimo, según la observación clínica directa. Para usos forenses, periciales o cuando hay incentivos secundarios evidentes, se recomienda complementar este informe con pruebas dedicadas de validez (p. ej. Rey-15, TOMM, MMPI-2-RF F/Fp scales).

Resultados Cuantitativos

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Vocabulario							+0.33
Aritmética							+0.00
Dígitos Directos							+0.33
TMT-A							-0.33

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a $+1$ σ).



Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Vocabulario	48	12	+0.33	Promedio
Aritmética	14	11	+0.00	Promedio
Dígitos Directos	11	12	+0.33	Promedio
TMT-A	35	9	-0.33	Promedio

Consideraciones de Aculturación y Escolaridad

Modulación cultural y educativa de los hallazgos

Los baremos empleados corresponden a la población colombiana cuando estuvo disponible (ENI-2, Neuronorma Colombia, Arango-Lasprilla & Rivera, 2017). Para pruebas sin normas locales se utilizaron las referencias originales, ajustando la interpretación al perfil sociocultural y escolar del evaluado. En contextos forenses esta consideración cobra especial relevancia: el desempeño puede verse modulado por escolaridad <8 años, bilingüismo, lengua materna no española o lateralidad mixta.

Síntesis Clínica Integradora

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil cognitivo se ubica globalmente dentro del rango normal esperado para la edad, sin debilidades ni fortalezas significativas en los dominios evaluados.

Resumen para la Familia

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Ricardo. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En Vocabulario, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Aritmética, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Dígitos Directos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

Fortalezas (lo que se hace bien)

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En Vocabulario, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Aritmética, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Dígitos Directos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En TMT-A, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.

¿Qué recomendamos?

Tu psicólogo/a te explicará las recomendaciones específicas para tu caso en la sesión de devolución. Algunas recomendaciones comunes incluyen: técnicas de estudio, estrategias de organización, o sesiones de seguimiento.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Necesito otro tipo de evaluaciones?

Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

Impresión Diagnóstica

Conclusión clínica · CIE-10 / DSM-5

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA DEL PROFESIONAL

Pendiente de diligenciar por el profesional.

Recomendaciones

Plan de manejo formulado por el profesional

RECOMENDACIONES

Pendiente de diligenciar por el profesional.

Anexo — Definiciones Operativas

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.

Glosario: palabras técnicas que usamos

Definiciones operativas de los términos técnicos utilizados en este informe.

CI / CIT

Cociente Intelectual Total. Medida global del funcionamiento intelectual con media 100 y desviación 15. Rango normal: 90-109. < 70 : déficit; 70-79: límite; 80-89: promedio bajo; 90-109: promedio alto; 110-119: promedio alto; 120-129: superior; ≥ 130 : muy superior.